고지혈증약(스타틴), 얼마나 센가요?

같은 스타틴이라도 **종류와 용량**에 따라 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 **약 22~55%**까지 낮춥니다. 중요한 것은 '상표'가 아니라 **강도 등급(고·중·저)**입니다 — 같은 등급이면 효과도 비슷합니다.

한눈에 보는 강도 등급

강도 등급	LDL 감소	해당 약·용량 (아래 표 기준)
고강도 (강한 약)	**≥ 50%**	로수바스타틴 20~40mg · 아토르바스타틴 40~80mg
중강도	**30~49%**	대부분의 표준 용량 — 로수바스타틴 10mg · 아토르바스타틴 10~20mg · 피타바스타틴 2~4mg · 심바스타틴 40mg · 프라바스타틴 40mg(경계)
저강도	**< 30%**	저용량·약한 성분 — 심바스타틴·프라바스타틴 저용량

스타틴 종류·용량별 LDL 콜레스테롤 감소율 (강한 순)

약 · 용량	LDL 감소율 (막대 길이 = 감소율에 비례)
로수바스타틴 40mg · 크레스토 등 · 고강도	55% ↓
로수바스타틴 20mg · 고강도	52% ↓
아토르바스타틴 40~80mg · 리피토 등 · 고강도	~51% ↓
로수바스타틴 10mg · 중강도	46% ↓
아토르바스타틴 20mg · 중강도	43% ↓
피타바스타틴 2~4mg · 리바로 등 · 중강도	~41% ↓
심바스타틴 40mg · 중강도	39% ↓
아토르바스타틴 10mg · 중강도	37% ↓
프라바스타틴 40mg · 메바로친 등 · 중강도 경계	30% ↓
심바스타틴·프라바스타틴 저용량 · 저강도	~28% ↓

※ 감소율은 임상시험(STELLAR, Jones 2003) 평균 · 강도 등급은 2018 미국심장학회(ACC/AHA) 기준입니다.

꼭 기억할 두 가지 — 증량보다 적정 강도, 더 낮춰야 하면 병용



간에서 덜 만들고, 혈관 속 LDL이 줄어듭니다

① 무작정 증량보다 '적정 강도'

6% 규칙 — 용량을 2배로 올려도 LDL은 약 **6%p**만 더 떨어집니다.
고용량 부작용(근육통·간수치)이 걱정되면, 증량 대신 **강도 등급에 맞는 약**을 고르는 것이 합리적입니다.

② 더 낮춰야 하면 '병용'

스타틴만으로 목표 미달 시 **에제티미브**를 더하면 LDL을 추가로 **약 18~25% ↓**.
스타틴 40mg + 에제티미브 병용은 심혈관 사건도 줄였습니다 (IMPROVE-IT 2015).

상표보다 '강도 등급'이 중요합니다

심혈관 위험을 줄이는 힘은 **LDL을 얼마나 낮추는가**에 달려 있습니다. 같은 **고강도**라면 브랜드가 달라도 효과는 비슷합니다. 내 위험도(관상동맥질환·당뇨 등)에 맞는 **목표 LDL**을 정하고, 그에 맞는 강도를 선택하는 것이 핵심입니다. **자몽주스**는 일부 스타틴 농도를 높일 수 있어 주의하세요.

함께 보기 — 진료실 설명 슬라이드: edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/dyslipidemia/ · 내 LDL 목표: edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/ · 결과지 읽기: edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/cholesterol-result-reading/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2018 ACC/AHA Cholesterol Guideline(강도 등급 표) · STELLAR trial(Jones PH et al. Am J Cardiol 2003;92:152-60) · IMPROVE-IT(Cannon CP et al. NEJM 2015;372:2387-97) · 한국지질·동맥경화학회

감소율은 임상시험 평균이며 개인차가 있습니다. 약 선택·용량은 주치의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-ldl-strength/